

maks



MAKS[®]-m

对认知障碍的 社会心理干预治疗

MAKS[®] 概念的负责人: Elmar Gräbel教授, 医学博士

本培训内容中文版权属南京南德认知健康科技有限公司所有

内容

第一章: MAKS疗法的方法和科学基础

第二章: 社会互动模块

第三章: 精细动作技能模块

第四章: 认知模块

第五章: 日常生活实践模块

第六章: 痴呆症症候群

第七章: 规划和准备

第一章: MAKS疗法的方法和科学基础

什么是MAKS[®]?



什么是MAKS® - m ?



MAKS® ...

- 是一个多种模式的、基于社会心理学原理的非药物**小组治疗方案**。
- 适用于轻度**认知障碍MCI**、轻度至中度**痴呆症患者**。
- 由四个**模块**组成，每次治疗按以下规定顺序完成四个模块：

S—社会互动和沟通

M—精细动作技能训练

K—认知训练

A—日常生活能力训练

为什么要使用MAKS® - m?



- MAKS® 的治疗方案的有效性是经过**科学证明**的。
- MAKS® 已被证明可以**更长时间地保持**患者的认知能力和日常生活技能。
- MAKS® 疗法可以根据一份内容丰富的**数字手册**来实施，手册中包含200多个精心设计的日间治疗计划及大量训练内容。
- MAKS® 利用现有资源和实践经验并对其进行重新组合。

为什么要使用MAKS® - m?



- MAKS® 是一项全面的**预防性方案**（初级预防、病情加重预防、症状行为预防）。
- MAKS® 符合“痴呆症 ”**S3指南** （德国关于痴呆症的治疗和照护国家准则）中如何处理具有挑战性的患者行为的要求。
- MAKS® 符合“护理过程中的关系管理”（强化自我认同和人格）的**专家标准（德国护理界的黄金标准）**

为什么要使用MAKS® - m?



- MAKS® 符合对“有行动障碍”和“有认知障碍”的两类风险群体的护理质量的管理要求。

德国长期护理保险联合机构制定的质量审查指南和系统信息收集（SIS）：

- 在尚存的行动能力方面提供支持
- 在解决日常活动问题方面给与支持
- 在日常生活内容组织、每天的时间安排、有意义的活动安排和相互沟通方面提供支持
- 对行为已有变化和有心理健康问题的人提供支持

时间	程序
10分钟	社会交往模块
30分钟	精细动作技能训练模块
10分钟	休息
30分钟	认知训练模块
40分钟	日常实践模块

(大概的时间)

数字化MAKS®的概述 - 手册



每个治疗单元的内容安排

第八单元		八月
准备工作:		- 为计划的练习提供材料 - 如果可能: 请使用日光灯 - 请准备好眼镜、助听器和姓名牌
时长	内容	
10 分钟	小组互动热场 1. 开始和欢迎仪式 (包括日期和时间) 2. 冥想: 4.1 呼吸运动	
30 分钟	(心理)-运动激活 1. 准备运动 2. 热身: 1.5 自选放松运动, 1-5 分钟 3. 主要部分: 2.4.23 自选摆动布练习, 如果要给出指示, 则没有音乐, 20-25 分钟 4. 准备休息	
20 分钟	休息	
20 分钟	认知能力激活 1. 热身活动: 1.2 “铅笔体操”, 约10分钟 2. 纸笔练习: 下载“纸笔练习”, 总共约20分钟	
40 分钟	日常行为能力激活 1. 主要部分: 4.5 看——表达感官, 约35分钟 2. 结束仪式	

点击手册

日程安排见数字手册

浅灰色字体
重复出现的内容
见数字手册

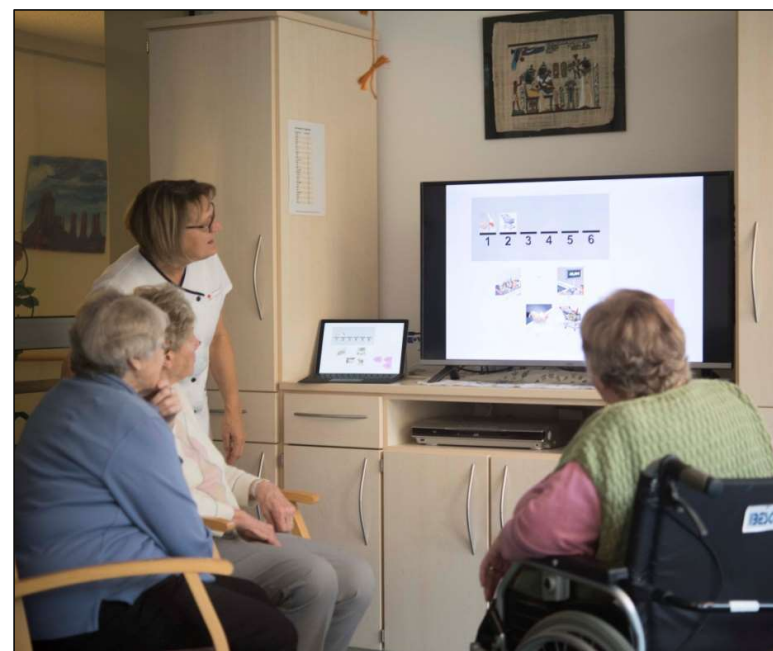


- 加入小组、成为一个集体
- 调动**社交资源**
- 尊重个体
- 加强**自我认同**
- 交谈与生活相关的话题

- 激活和保持**精细动作技能**
- 促进**身体行动能力**
- 促进**身体协调能力**
- 促进**身体平衡感**
- **加强身体肌肉力量**
- **改善身体自我感知**



- 激活和保持**认知能力**:
*注意力、专注力、语言、视觉空间思维
能力和记忆力*
- 训练**逻辑思维**
- 保持文化知识技能
阅读、写作和计算





- 激活和保持**日常生活技能**
- 训练**日常生活中的工具使用**
- **激发社会沟通能力**
- 参与日常生活实践
- 体验普通**日常生活**

对于有**认知障碍**的人：

- 维持尚存的独立生活能力
- 改善情绪症状和行为症状
- 改善生活状况和生活质量
- 鼓励参加集体活动
- 获取成就感

对**照护者**和患者**周边的人**

- 日常生活安排得到改善
- 积累新的治疗知识和经验
- 患者维持其尚存的独立生活能力可以减轻照护者负担
- 通过改善患者的社会行为以减轻照护者负担

- **多维模式：**精细动作能力的激活、日常生活技能的激活和**认知能力的激活**，以及满足对社会互动和沟通的需求。
- **方案丰富：**系统且多样的干预内容（MAKS®数字手册）。
- **规律性：**可供每日使用，每次约2小时，在上午进行，形成固定的日常安排。
- **针对性：**根据患者不同的认知水平可采用不同难度的练习内容；由1-2名治疗师进行，大约10人一组。

基础知识 学术背景



- 目前还无法通过服用药物来**避免**患上痴呆症。
- 目前还没有一种有效的、副作用很小的药物能够**治疗**痴呆症。
- 国际上，只有少数几个多维度的、经临床证明的、非药物治疗的方案。

德国政府颁布的关于痴呆症患者的S3治疗指南 - 第68页

“在使用精神药物治疗行为症状之前，应进行精神病理学诊断。首先必须寻找医学的、个人的以及环境对其行为形成的因素，并尽可能对其加以处理或改变。此外，在社会心理干预措施无效、不充分或无法实施的情况下，可以使用药物干预。...”

德国的治疗频率：

- 门诊病人（确诊后2年内）：**48%的患者服用药物** (Bohlken等人, 2017) 。
- 在养老院：**52%的患者服用药物** (Huber等人, 2012)

痴呆症患者服用药物，出现以下不良反应：

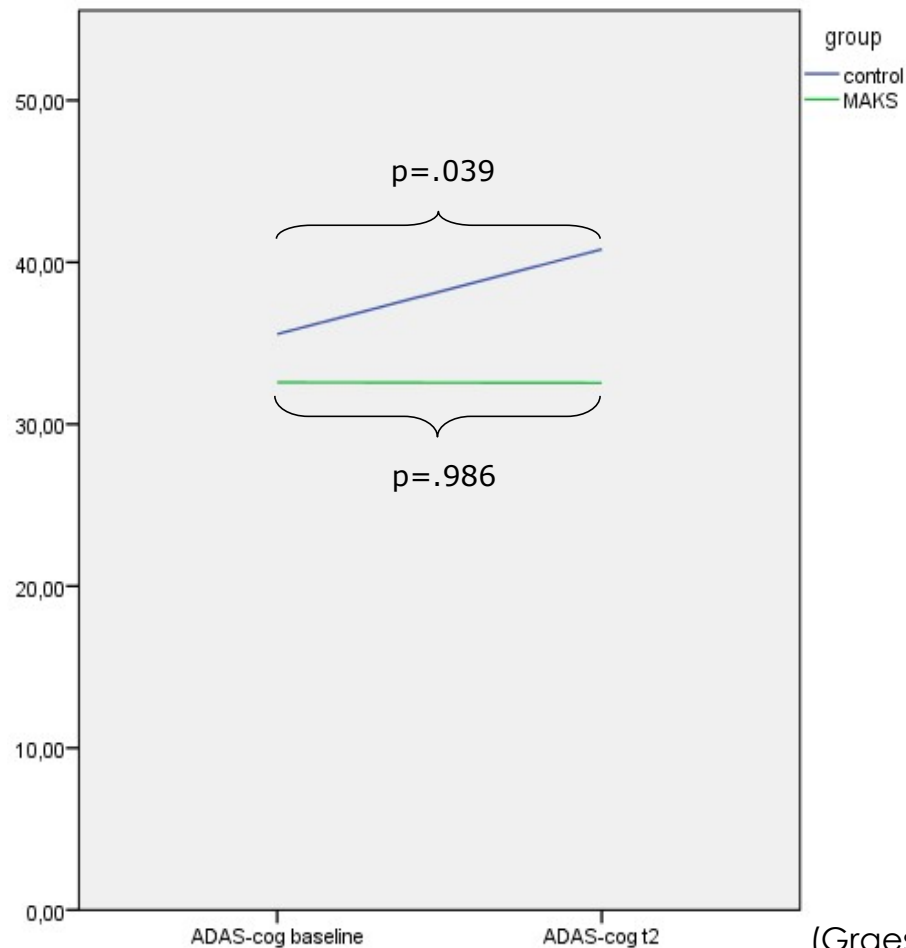
- a) 身体动作方面的副作用（类似帕金森病）。
- b) 跌倒的风险增加（因镇静中枢神经）。
- c) 由于中枢神经减弱导致的认知能力下降
- d) 更大的中枢神经减弱导致更频繁的跌倒事件（减弱得分, Lippert et al, 2020）。
- e) 死亡率增加

- 在治疗指南中，建议**首先尝试非药物治疗!**
- **不应该用**镇静药物来**代替**对患者的照护措施!

MAKS® - 在护理院进行的临床验证（2008 - 2010）。



- 在5家不同护理院进行
- 不同程度的痴呆症患者参与
- 德国联邦卫生部（BMG）提供研究经费。
- 随机对照试验



(Graessel等人, 2011)

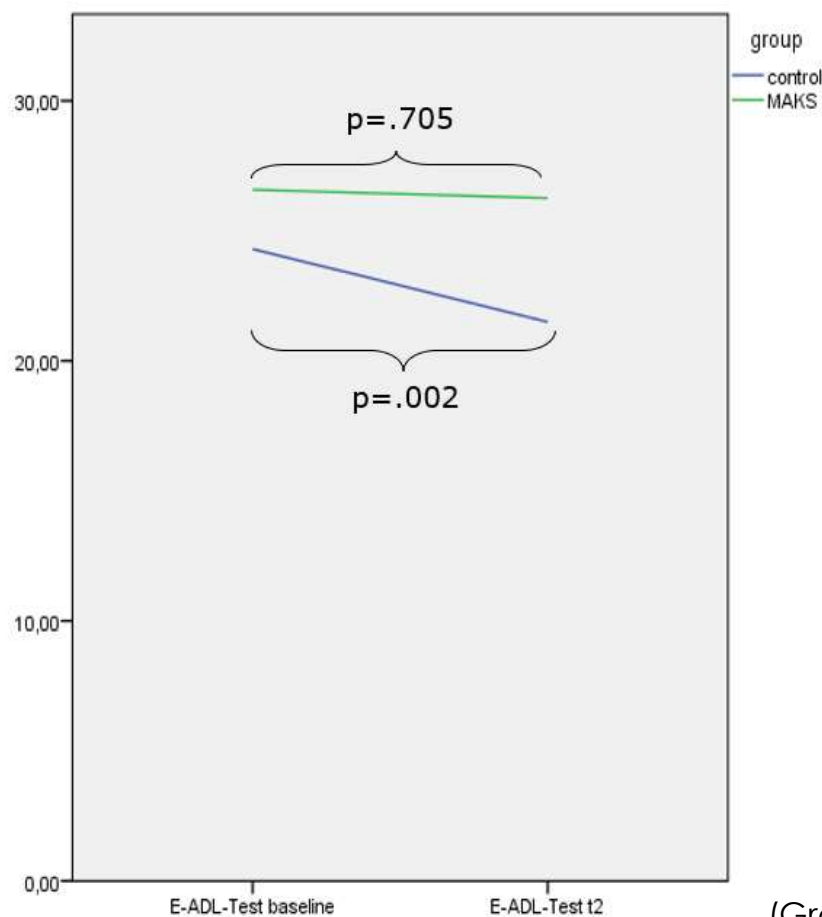
ADAS-cog测试:

阿尔茨海默症评估量表，有记忆、语言、注意力、日常练习等11项任务。

数值越低，认知能力越强

12个月: $n = 61$

在12个月的治疗期间内，参与干预组的老人维持原有的认知能力水平



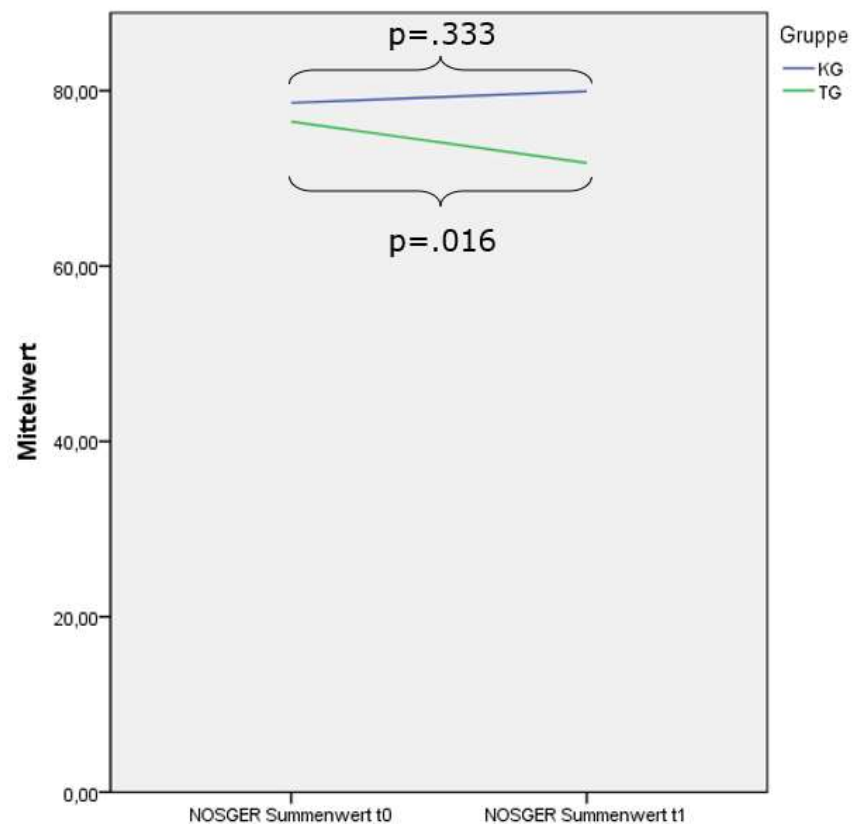
(Graessel等人, 2011)

E-ADL测试:

Erlanger ADL测试有5项复杂的日常工作--倒饮料、切面包、开橱柜、洗手、打蝴蝶结。数值越大，日常生活技能越强

12个月: $n = 61$

在12个月的治疗期间内，参与干预组的老人维持原有的日常生活技能



NOSGER (老年病人护士观察量表) 有6个维度--
记忆、IADL(基本生活技能)、ADL基本身体活动技能、情绪、社会行为、不受欢迎的行为。

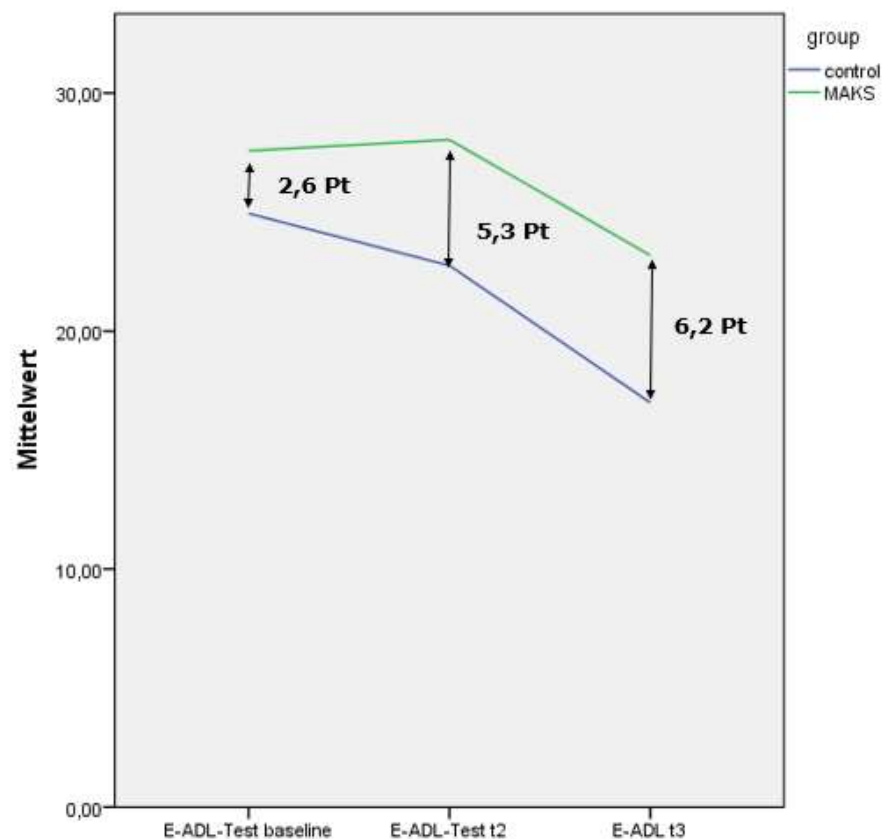
6个月: $n = 79$ (AT分析)

MAKS的实施对干预组的老人行为产生了积极影响

↑ 社会行为和情绪、
↓ "挑战性" 行为
↓ 抑郁症

(Luttenberger, Donath et al. 2012)

临床试验结束后的日常实践技能对比



MAKS[®]组:

第1-12个月(基线-T2):

实施MAKS[®]治疗

第13-22个月(T2-T3):

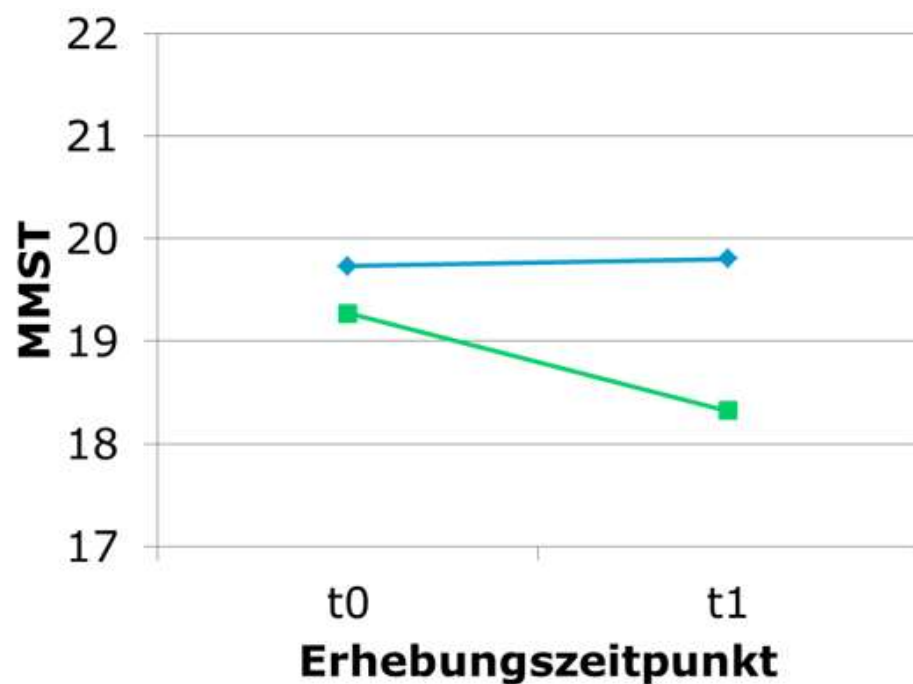
不再实施系统的MAKS[®] 治疗

(Luttenberger, Donath et al. 2012)

- MAKS® 对谁有效？ **轻度认知损伤患者--轻度/中度痴呆**（MAKS® -m疗法）。
- "m "代表轻度认知损伤(MCI)， 轻度或中度痴呆症患者。
- **对于严重痴呆患者**（简易精神状态检查量表， MMSE: 0-9分）， MAKS® -m 治疗效果不显著（Graessel等人， 2011年）。
- **对于严重痴呆患者**可以实施MAKS® -s（小组式干预， 持续时间1小时， 较简单的锻炼内容， 如祈祷（S）， 运动歌曲（M）， 感官主题（K）， 涂抹面包（A）， 从2022年开始培训课程）。

- **在日间护理机构进行验证的DeTaMAKS(2014 - 2017):**轻度认知损伤(MCI)或轻度至中度痴呆症患者(随机对照试验)
- GKV-Spitzenverband (法定医疗保险联合会总会) 和巴伐利亚州卫生和护理部提供研究经费
- MAKS® 得到进一步的发展和调整, 以适应生活在家中并定期参加日间照护的认知障碍者的需要。

————→ MAKS® -m (新数字手册)



简易精神状态检查量表 (**MMSE**) :

快速测试, 包括方向感、记忆力, 注意力、算术、记忆、语言等任务。范围为0-30分。27-25分MCI, <25分痴呆症。

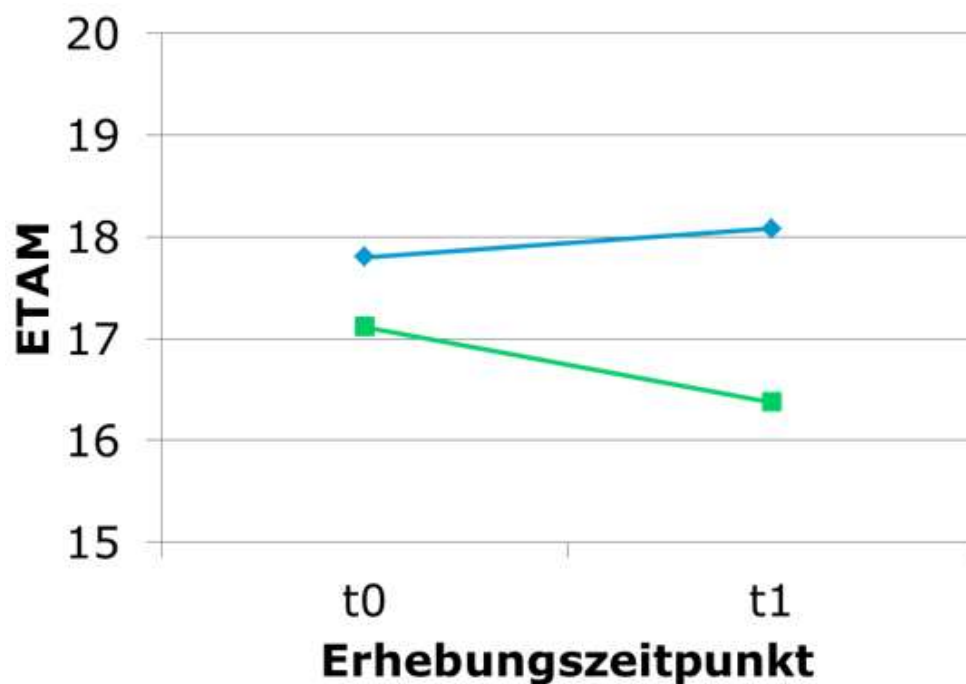
结果: 在6个月的治疗期间内, 参与干预组的老人维持原有的认知能力水平

—◆— 干预组, n = 208

—■— 对照组, n = 154

(Straubmeier, et al. 2017)

图: 对照组与干预组的MMST值在t0和t1的变化过程比较。



日常实践技能评估:

作为E-ADL的更困难的任务：打电话、交通状况、火车时刻表、吃药、泡茶、设置闹钟、洗漱、财务。

结果：在6个月的治疗期间内，参与干预组的老人保持、甚至略微高于原有的日常生活实践水平

—◆— 干预组, n = 208

—■— 对照组, n = 154

(Straubmeier, et al. 2017)

图：对照组与干预组的MMST值在t0和t1的变化过程比较。

- 6个月后，在被问到干预组老人是否还有神经精神清单（妄想、幻觉、躁动和攻击性、抑郁、日/夜节律紊乱）的症状时，被提问者（照护者）普遍观察到干预组老人表现出**较少的情绪、行为和其他 "神经精神 "症状**（效应大小： $D = 0.23$ ）。

轻度认知损伤（MCI）平均显示出与痴呆症患者相似的病程（Straubmeier等人，2017）。

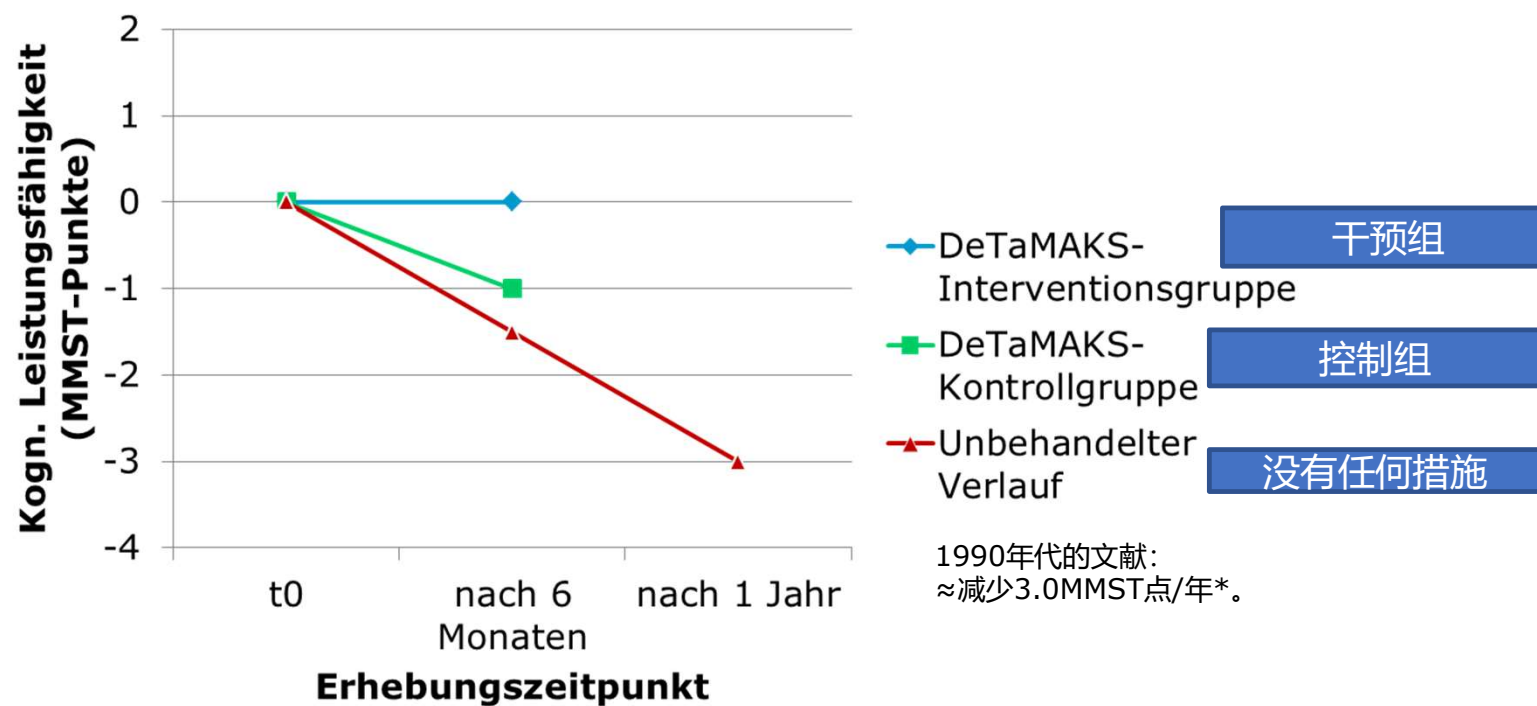
结论：因此，MAKS® -m对轻度认知损伤的患者同样有效。

因此，鉴于72%的MCI患者在5年内会发展成痴呆症患者（Inui等人，2017），MAKS-m具有预防作用，即防止MCI患者成为痴呆症患者。

（而根据Digidem2020年5月的研究结果，在26%-50%的MCI患者中，精神状态会恢复正常。这表明，MCI的过程不一定会导致痴呆）。

研究表明，对于那些定期每周参加**1-2次**日间护理的人来说，MAKS®疗法的影响强度，与每周参加3-5天日间护理的人，是一样的（Straubmeier等人，2017）。

结论：对居家养老的认知障碍患者，通过在日间照护机构每周参加1-2次的MAKS®治疗，就可以取得效果。

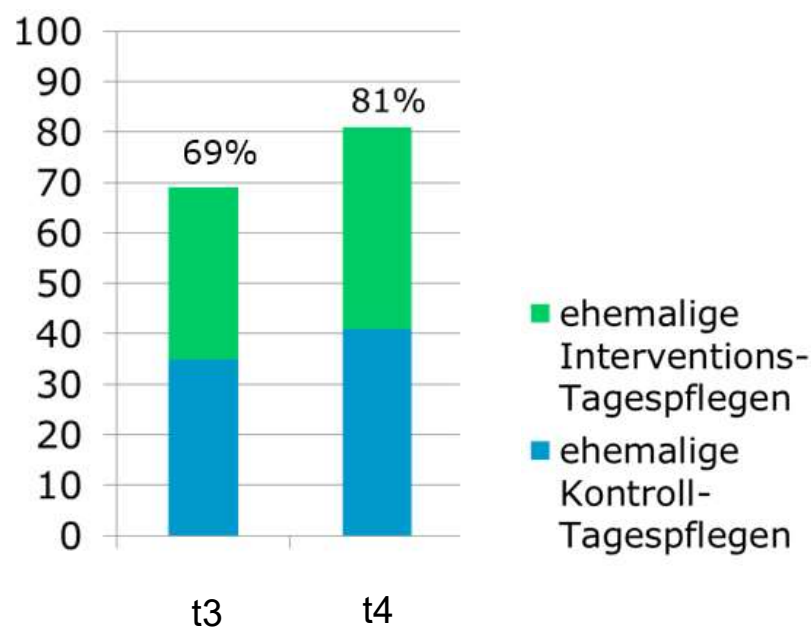


*未经治疗的痴呆症每年在MMSE点数上的进展情况

阿尔茨海默型痴呆约2.8 (Salmon等人, 1990年)。

在所有形式的痴呆中 (包括血管性痴呆) 为3.2 (Cohen-Mansfield等人, 1996)。

“你是否继续实施MAKS® 疗法- 是/否？”



图：研究结束后实施MAKS®的日间护理中心的百分比；

- **T3:** 研究结束后6个月。
- **T4:** 研究结束后18个月

结论：在 临 床 研 究 结 束 后，所有实施MAKS®的机构的份额，随着时间的推移又有所增加。

(Gräbel等人2019年，DGG大会摘要)

- MAKS® 在多维度干预治疗法中是唯一做到了干预组的**日常生活实践技能**得分明显高于对照组。
- MAKS® 是唯一一个在**所有基本结果变量**（认知和日常实践）**上**，干预组的得分都明显优于对照组的多维度干预疗法。
- **系统综述（Yorozuya等，2019）**：7项多维度的非药物干预的国际比较研究显示，每周3次的运动、认知和日常生活训练的组合最为有效。而MAKS-m疗法的研究被评为最优。

MAKS® ...

- ...在应用MAKS®疗法期间**保持能力不变**（认知和日常生活实践）（在临床试验6个月或12个月期间）。
- ...**减少**痴呆症患者**情绪和行为症状**。
- ...在**日间照料中心和全托式养老机构**，MAKS都可以发挥作用。

- 患有轻度认知障碍**MCI**、**轻度和中度痴呆**的人从**MAKS®**疗法中受益。
- **每周1-2天实施MAKS®** 也同样有效。
- **通过4个维度的干预措施的结构化安排**, **MAKS®** 的有效性得到了证明。

治疗原理

为什么MAKS® 有效



maks



理想的认知触发的环境是 "多维的", 包括:

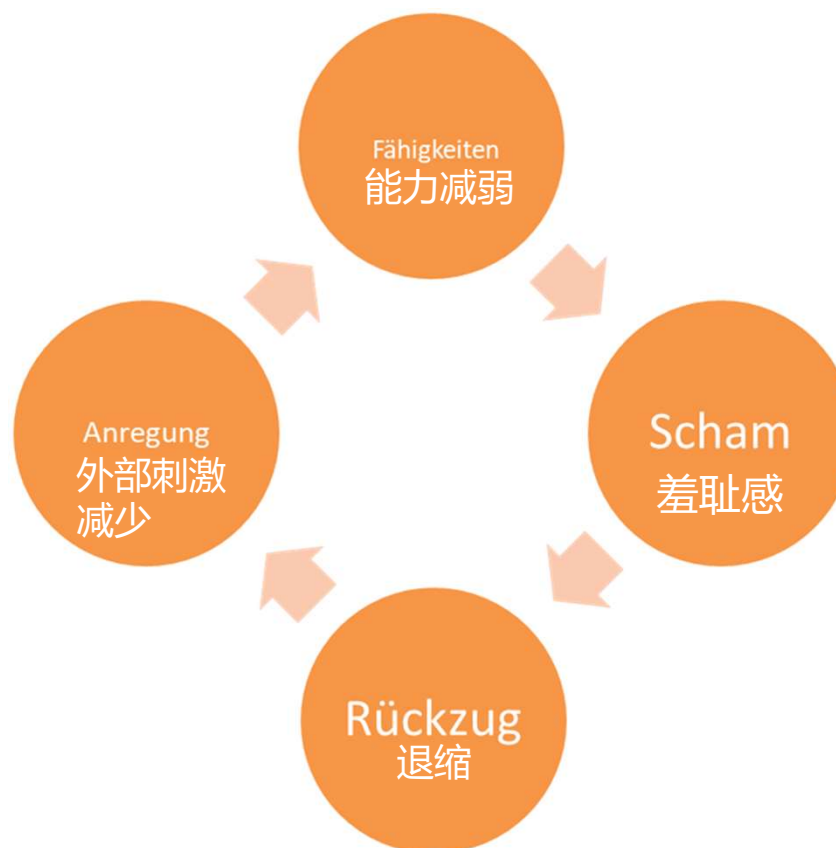
- 对认知的要求
- 身体动作/精神活动
- 日常生活实践活动
- 沟通和社会互动

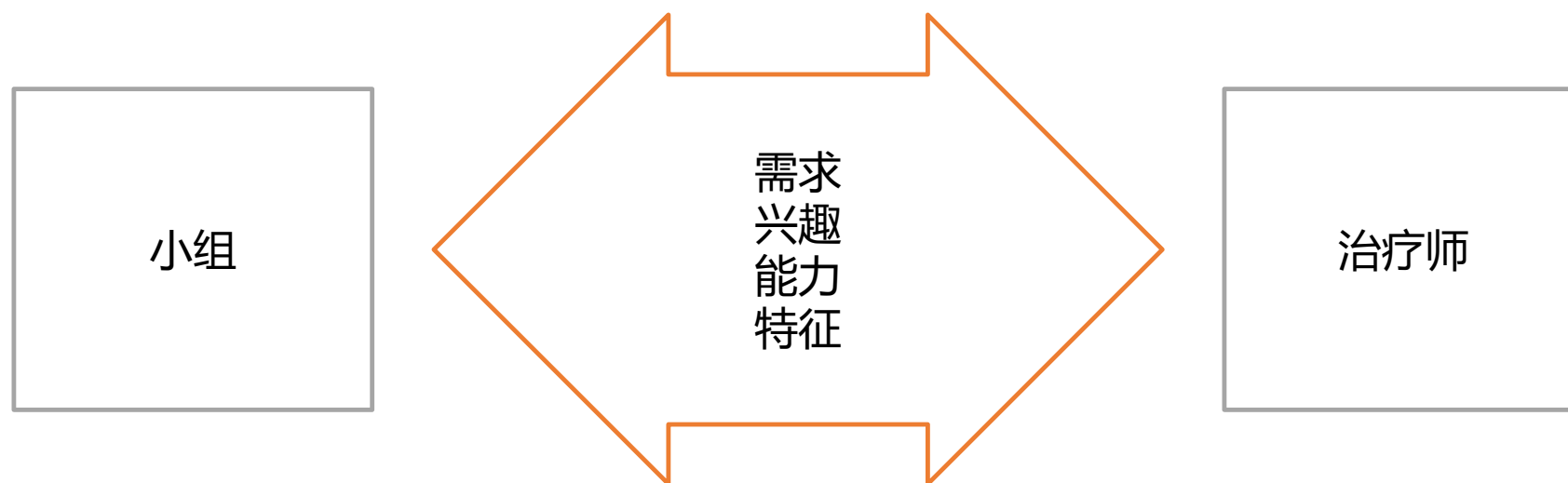
通过应用MAKS®疗法 ...

- “神经元可塑性”受到了刺激。
- 减缓大脑神经细胞之间接触点分解过程。

注释：“神经元可塑性”（新的神经细胞的出现和它们之间的连接）在整个生命周期都存在（但随着年龄的增长，可塑性强度会下降）。

认知能力退缩的恶性循环 (根据Gräbel & Straubmeier)





基本态度	结构原理	一般性原则	个性原则
同理心/面对、倾听	日常生活中的习惯仪式/固定做法	所有感官的刺激/生活的不同方面	日常决策中的自主权
尊重	因材施教	平等相待	给个人兴趣提供空间
真实	熟悉的、愉快的环境	轻松的引导	注重个人技能
保持距离和亲近的关系	集体/团队	完成的喜悦感	鼓励老人自己尝试，尽可能少的帮助

- **小组中避免竞争**，提倡团结一致，互相帮助
- 尽可能地允许和照顾个人选择和偏好
- **鼓励主动性**
- 通过使用不同难度的干预内容，尽量避免实施的内容对老人来说太容易或太难
- 鼓励各模块之间的交互使用（例如，算数练习[**认知**] "苹果" [**日常实践**] 和 "骰子水果的颜色" [**运动**]）。

- 具备一定的经验，并能结合自己的长处
- 最重要的是自己对治疗师角色的满足，并乐于和小组互动。
- 擅长唤起人们的好奇心；自己也保有好奇心
- 真诚的赞美
- 具备专业的知识

第二章: 社会互动模块





- 加入小组、成为一个集体
- 促进**相互联系与交流**。
- 得到尊重
- 加强**自我感知**
- 讨论生活中的有关话题

10分钟	社会互动模块 1. 欢迎到场并烘托气氛 2. 引导和提示：1.4 朗读一首春天的诗歌（汉化版：歌曲，春天在哪里？） 3. 相互交流：憧憬春天。今年春天我最期待的是什么？
------	---

- **欢迎仪式和烘托气氛**是社会互动模块的一个固定组成部分。
- 每个治疗单元可以轮换进行**四种不同类别的认知刺激**。

欢迎到场：

- **个人问候：**
每个参与者问候他身边的
邻坐, 尽可能叫出名字。
- **保持和加强身份：**
感觉是在关注**我**，在和**我**说话，**我**变得
重要

欢迎仪式—音碗
约1分钟

烘托气氛的仪式—举例

- 一起唱一首歌
- 宣读当天的座右铭
- 一起念一首诗（例子 数字手册 → 如何使用MAKS® 方案包 → 重复的部分）
- 引起注意力的仪式（音碗或类似的）。
- 点燃蜡烛
- 家中常见的早晨仪式

社会互动模块可轮换实施**四个类别的社会互动**刺激，每次治疗中可挑选其中一到两类进行：

1. 中心的设计
2. 引导和提示 (就某一话题)
3. 相互交流
4. 冥想/正念

安排和装饰椅子圈的中心，强调作为一个团体的共同点，并为之后的内容做铺垫。

给予参与者思考的机会，以激发联想。

- 介绍当天的主题

例如："今天的主题是春天"。

- 简要说明该主题

例如："春天是一个季节....."。

- 设计一个切入点

例："今天早上我看到了一朵郁金香（汉化版：桃花）"。

- 关于主题的诗歌或歌曲（数字手册，社会模块）。

- 分发感性的物品（郁金香，汉化版用桃花）。

- 与会者分享他们自己的经验、回忆和想法。
- 治疗师与老人直接交谈，并积极回应他们提供的内容。
- 重要的是：不要问事实性的内容（语义记忆内容），而是问**个人经历**（情节记忆内容）。
- **比如说：**“你什么时候经历过.....？”/“.....让你想起了什么？”/“这对你意味着什么？”

加强此时此刻的存在感和训练感官的**练习**

例子见数字手册：社会模块，4.冥想/正念

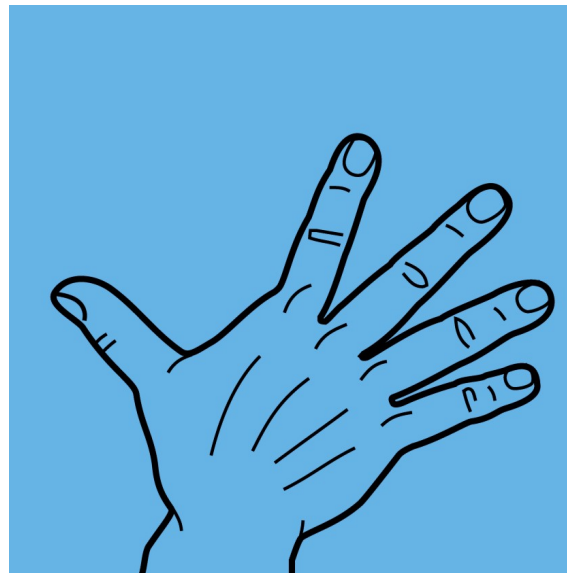
呼吸练习示例（见数字手册，社会模块，4.1）。

"我们现在要专注于我们的呼吸。要做到这一点，我们要坐直，把我们的脚并排放在地板上。如果你愿意，你也可以闭上你的眼睛。我们让呼吸均匀地流进和流出。我们给自己每次呼吸所需的时间。我们让空气流入我们的肺部（吸气）并再次呼出（呼气）。我们注意到它们如何被空气填满，空气如何从它们中排出，我们的腹壁如何上升和下降。让我们试着在吸气后停顿片刻，然后再把空气释放出来。吸气-停留-呼气"。

汉化版：先试着让自己安静下来，找到让你觉得舒服的姿势，你可以选择坐下、躺下、或者靠在椅子上，当然，站着也是可以的。当你准备好了，开始做几次深呼吸，让心安住在当下。用鼻子吸气，用嘴巴呼气，深深地吸气吸气、缓缓地呼气，再来一次吸气、呼气，注意你的呼吸，深深地吸气，缓缓地吐气，尽可能的延长你的呼吸，让呼气的时间比吸气的时间更长一点。在你下一次呼气的时候，慢慢地闭上你的眼睛，这样做让你对身体的感觉有更多的觉察然后让你的呼吸回到自由的节奏，用鼻子吸气，用鼻子呼气。这是你可能冒出很多想法，没有关系，你可以让自己想旁观者一样在旁边静静地观察、感受这些想法，你只需要慢慢感受这样安静的感觉，什么都不做，我们就这样安静地待一会。

重复呼吸数次。你也可以使用你自己的呼吸练习或对其进行改变/延深。

第三章: 精细动作技能训练模块



- 激活和保持精细动作能力
- 加强身体行动的能力
- 锻炼身体的平衡感
- 促进身体协调能力
- 促进身体的自我感知



30分钟	精细动作技能训练模块 1. 启动活动仪式 2. 热身运动：1.1 简单的热身和放松，1-5分钟 3. 主要部分：2.4.29 用双打棍练习20-25分钟 4. 准备休息的仪式
------	--

例子:

- 简单的热身和放松动作
- 用球进行热身
- 根据场景进行相应动作热身
- 正反动作
- ...

见数字手册-- (Senso-) 精细动作技能训练
模块, 1。





例子:

- 手持器械操练
- 动作游戏（保龄球——**汉化版用塑料瓶代替**、瞄准投掷、堆叠游戏）。
- 运动跑酷
- ...

见数字手册- (Senso-) 精细动作模块, 2
。

“擦亮眼睛、
打开心扉、
带上微笑
深深的呼吸。”

休息!

第四章: 认知模块

理论背景



痴呆症的定义 (ICD-10)

痴呆症是一种由通常的慢性或退行性大脑疾病导致的综合征，**许多高级皮质功能受到干扰**，包括记忆、思考、定向、理解、计算、学习能力、语言和判断。**意识不是模糊的**。认知障碍通常伴随着**情绪控制、社会行为或动力的改变**。

欧洲的患病率：80-84岁为14.35%，85-89岁为23%，大于90岁为36.3% (WHO, 2021)。

德国的痴呆患者：2021年为180万。预测2050年将有280万65岁以上的人。

2021年德国的新病例：44万名65岁以上的人。

(中国2021年，60岁及以上老年人中约有1500万痴呆患者，其中1000万是阿尔茨海默病患者，轻度认知损伤(MCI)患者数为3877万例)

阿尔茨海默氏痴呆症：年龄较大，记忆障碍是主要症状

血管性痴呆：血管性原因，认知障碍，有阶段性的轻微改善

混合性痴呆：阿尔茨海默氏病和血管性痴呆，大多数受影响的人

帕金森病痴呆：行为特征，如冷漠、人格改变、情绪低落和焦虑。

额颞叶痴呆症：中年时出现人格改变和丧失社交能力

路易体痴呆：> 觉醒，运动性帕金森病症状，视觉幻觉。

早期诊断很重要!(Keller C. 2016)

1. 认知症状

- a. 记忆障碍
- b. 其他高级皮质功能受到影响

2. 日常活动受到影响

3. 情绪症状和行为症状（非认知性症状）。

1 a.对 "新记忆 "的损害

新记忆：新信息的**接收和储存** („记得“) 和**再叙** (”回忆“) 受阻。

患有痴呆症的人...

- ...不记得他们的家人上午来过。
-不知道他们刚刚吃过什么东西。
- ...一遍又一遍地问**同样的问题**。
- ...一遍又一遍地讲述**同样的内容**。
- ...努力保持在接受信息的面部表情。

1 α.旧记忆 "的损害

- **情节记忆的内容：**以时间-空间为参照的信息存储（“个人生活经历”）。
- **语义记忆的内容：**存储的信息与背景无关（“事实性知识”）。
- **程序性记忆内容：**属于所学动作序列的信息（“执行功能和日常技能”）。

(根据Markowitsch 2009的分类)

1 a. “旧记忆”的损伤的表现形式？

- 生活经历情节的顺序打乱。
- 个别事件想不起来了，例如 "我从未结婚"。
- 打牌的时候，分不清大小（如德国羊頭牌："上"胜"下"，在中国可以理解为扑克中的Q胜小王J）。
- 驾驶手动挡汽车忘记挂挡和踩放离合器的顺序，...
- 长时间掌握的、并无数次训练过的动作序列被打乱或消失（无法完成含有复杂动作顺序的任务）。

1 b.高等皮质功能的损害

表现在以下几个方面受到损害或影响：

- 注意力
- 语言表达
- 视觉空间思维
- 执行功能（见日常实践模块）。

1 b.注意力

- **选择性注意力**：选择或引导意识集中到某个特定的感知，同时屏蔽掉其他干扰，例如阅读。
- **灵活的注意力**：注意力的切换，如驾驶汽车
- **分配注意力**：能够将注意力交替地集中在两个或更多的刺激源上，例如使用电脑。
- **集中注意力**：持续将注意力集中在某一个内容

患有痴呆症的人...

-往往很快就会感受到过度感官刺激。
-开着电视的时候几乎无法进行谈话。
-会因谈话而分心
-很难在两种选择中做出决定。

(根据Niemann & Gauggel, 2010)

1 b.语言

对以下两种情况进行区分：

- 因身体部位功能引起的说话**障碍**
- 因对语言理解引起的语言表达**障碍**。

例子：文不对题，找词困难，命名障碍，断句，机械地使用成语和熟语，在晚期阶段：语言枯竭。

1 b.与语言障碍患者互动指南

- 尽量用短句，句子结构简单，避免使用外来词
- 说话缓慢而清晰
- 不要宣读长篇文字
- 与痴呆患者眼睛平视说话（视觉接触）。
- 给对方时间（不要催促对方回答）。
- 不要设置非此即彼的问题（因无法选择）。
- 不要问为什么（因无法解释）。
- 利用非语言方式进行沟通，比如身体接触
- ...

1 b.视觉空间思维

术语“**视觉空间障碍**”包括识别二维或三维形状（如照片和时钟）或根据模型或记忆构建它们的**能力的障碍**，即绘制或组装能力受损。

患有痴呆症的人...

(文献: Kernath等人2017年之后)

- ...在识别面孔时有困难
- ...在识别物体时遇到困难
- ...把组件完整组装起来，会遇到困难。
- ...在画物体时会遇到困难。
- ...完成拼图时会遇到困难。

Busse, A., Hensel, A., Gühne, U., Angermeyer, M., & Riedel-Heller, S. (2006). 轻度认知障碍。四种临床亚型的长期过程。《神经病学》，67 (12) , 2176-2185。

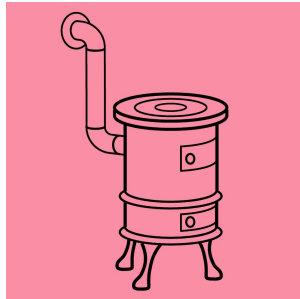
德国阿尔茨海默病协会 (2016) 。信息表1.痴呆症的发病率。柏林：德国阿尔茨海默症协会e.V. Selbsthilfe Demenz。

Dilling, H., Mombour, W., Schmidt, M. H., & Schulte-Markwort, E. (编者) 。(2013).《国际精神疾病分类CD-10第五章 (F) 临床诊断指南 (第九版) 》。伯尔尼：Huber。

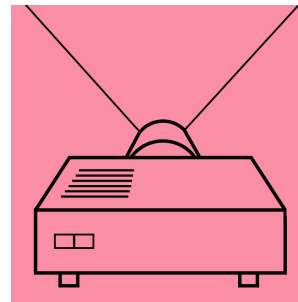
Karnath H.-O., Zihl J. et al. (2017).S1-Leitlinie Rehabilitation bei Störungen der Raumkognition 2017. In: Deutsche Gesellschaft für Neurologie, ed. Guidelines for Diagnostics and Therapy in Neurology. www.dgn.org/leitlinien Markowitsch H.J. (2009) .《记忆》。慕尼黑：Beck。

Niemann & Gauggel (2010).注意力障碍。In Frommelt & Löslein (eds.), *Neurorehabilitation*.柏林：Springer, 第145-170页。

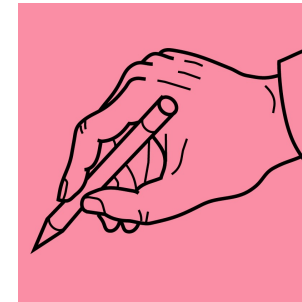
认知模块的实施内容



热身运动



投影练习



纸笔练习

目标

- **激活和保持认知能力**，如注意力、集中力、记忆力、逻辑思维、 ...
- **保存读、写和算术的文化技能**

程序 - 例子

30分钟	认知模块 1. 热身运动：1.2铅笔操、 10分钟 1. 纸笔练习，共约20分钟
------	--

练习有**不同难度**，尽可能地避免过难或过易。

这些任务涉及不同的**认知区域**：

- 新的记忆
- 旧记忆（语义记忆）
- 语言
- 注意力
- 视觉空间能力
- ...

精细动作热身练习

用笔做操

手指练习

分类练习

- 建议**将彩色的练习页贴膜**，让参与者用可擦拭的彩笔在上面完成任务。
- 通常可以找到**特定主题的任务**，例如，主题为春季：字母计数文本与春季有关，ABC练习与春季有关。
- **根据适当的难度**选择练习。

用笔做体操 - 约2分钟

2人小组的作业

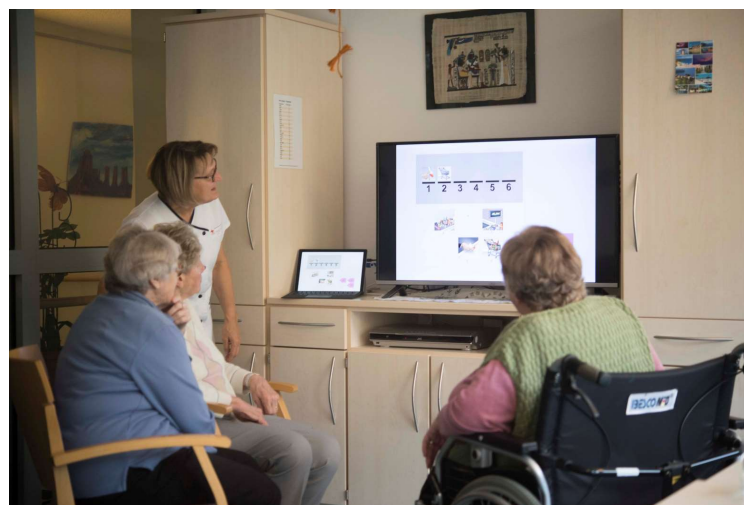
每个小组介绍自己选用的认知训练题目：

- 练习题的内容是什么？
- 参与者应该做什么？
- 如何布置这项练习？
- 有哪些难度？
- 针对哪个认知区域（如新记忆、旧记忆、语言、注意力、视觉空间能力等）？



运动类型	对应的认知能力
ABC练习（汉化版：数字练习）	语言生产、写作
抄写字母（汉化版：抄写汉字）	写作
标记成对的字母（汉化版：标记成对的汉字）	选择性注意
字母计数（汉化版：数汉字）	选择性注意
临摹彩色图案	视觉空间技能
删除任务	选择性注意
日历任务	旧的记忆，写作
画线	视觉空间技能
临摹	视觉空间技能
句子和词连线	语义记忆
结对	选择性注意
骰子游戏	算术，写作
根据示意图计数	视觉空间技能
标记成对的数字	选择性注意

- 参与者在屏幕前坐成一个**半圆形**。
- **认知练习**出现在屏幕上，由参与者共同回答。
- 请确保不要出现认知能力较强的一个人回答所有问题，尽可能让每个人都参与。



运动类型	这特别针对哪种认知能力?
命名	旧记忆 (语义记忆)
命名和联想	旧记忆 (语义记忆)
猜图片	旧记忆 (语义记忆)
图片补充完整	空间-视觉思维, 旧式记忆 (语义记忆)。
对图片内容进行排序	执行功能
你知道吗?	旧记忆 (语义记忆)
觉察	新的记忆
找对子	选择性注意
排序练习	执行功能
Richodo游戏	新的记忆
找影子	选择性注意
数独	执行功能
找标志	选择性注意
应用题	计算
活动	旧记忆 (语义记忆)
配对	视觉空间思维
知识问答	旧记忆 (语义记忆)
猜测词	旧记忆 (语义记忆)

第五章: 日常生活实践模块

理论背景



受到影响的日常生活

- **日常生活的基本活动 (ADL)** : 个人卫生、穿衣、吃饭、走路、爬楼梯、上厕所。
- **日常生活中使用工具活动 (IADL)** : 操作自动取款机、打电话、购物、做饭。

执行功能

...是较高级别的认知过程，它控制着几个步骤的协调以实现一个确定的目标（文献根据 Müller 2012）。

执行功能 -- 步骤分解

- 设定一个目标
- 设计一个行动计划，将计划分解为行动步骤
- 确定正确的步骤顺序
- **将注意力**集中在追踪目标上
- **调集大脑中程序性记忆内容**
- 关注每个步骤的完成
- 检查中间目标的完成情况

例如：泡茶

执行功能的下降、

...因**精细动作技能**的下降而加剧、

...导致**日常生活**技能的下降/丧失。

例子：患有痴呆症的人...

- ...在某些迄今为止他们一生都能做到的动作上犯错（例如使用电话、刷牙）。
- ...以至于他们不能**再独立处理**他们的日常生活。

日常生活实践模块内容



- 激活和保持
日常生活实用技能
- 促进
社会 沟通能力
- 参与
日常生活内容
- 体验
正常的日常生活
- **训练工具的使用技能**



40分钟

日常实践模块

1. **主要部分：2.15建造姜饼屋**，约35分钟
(汉化版：用积木搭建房子)
2. 闭幕仪式

利用患者尚存的认知和行动资源在社会交往情景下进行日常活动的实践。

MAKS® -m包括以下日常生活中使用器具的训练：

- 精细动作练习和生活技巧
- 手工练习
- 按菜谱做饭
- 感官刺激
- 游戏
- 其他活动

根据一年四季和文化背景：

- 在四月画复活节彩蛋 (汉化版：画京剧脸谱)
- 春天的播种盘
- 准备用季节性水果制作水果沙拉
- 在秋天制作苹果酱 (汉化版：端午做粽子, 中秋做月饼)
- 在圣诞节期间烘烤饼干 (汉化版：做元宵)

根据能力和喜好分配任务：

- 有**轻微痴呆**的人被赋予**更难的任务**，例如分离蛋黄和蛋白。
- **痴呆程度较重**的人被赋予**更容易的任务**，例如切水果。
- 善于处理数字的人称重。

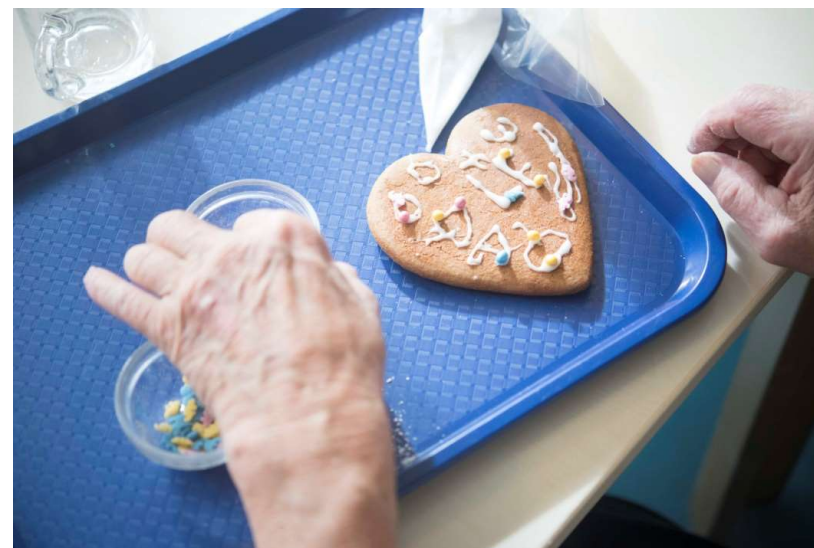
精细动作练习和生活技巧

- 量尺寸
- 摆图
- 估算
- 使用橡皮筋



手工艺练习

- 注意容易吞咽的小部件
- 注意：工具带来的伤害风险





根据菜谱准备食物

10人份的菜谱



感官的刺激

- 增强关注力
- 激活和维持引发记忆
- 激活感官：嗅觉、味觉、听觉、触觉

游戏

- 熟悉的大型厅堂游戏：如巨型天皇、巨型拼字游戏、鲁道、多米诺.....。
(汉化版：抛绣球、五子棋、跳棋, 用筷子玩Mikado)

其他活动

- 筹划出游活动和节日活动
- 舞入五月 (汉化版：广场舞)
- 摆放咖啡桌 (汉化版：准备待客茶点，例如瓜子、花生等)

第六章: 痴呆症候群

情绪化的症状
和行为症状

1. 认知症状
 - a.记忆紊乱
 - b.其他高级皮质功能的损害
2. 日常生活活动受到限制
- 3. 情绪和行为症状（非认知性症状）。**

症状

- 恐惧
- 抑郁症
- 无法控制冲动
- 兴奋性/挑动性升高
- 言语-身体-性侵犯性提高
- 冷漠/动力下降/无精打采
- 妄想/幻觉, 伴有或不伴有痛苦...

原因

大脑的有机变化；疼痛和其他医学原因；环境因素（不利的交流 参照基特伍德的非人格化行动，环境变化）；患者无法交流的未满足的需求（寻找失去的东西、寻找家、寻找熟悉的东西.....）。

对患有痴呆症患者的激励和规范 (1)



给痴呆症患者带来幸福感的活动 (Mamun 等人BMC 2022研究结果):

1. 和家人在一起(最重要的需求)
2. 可以自己决定每天的活动安排和内容
3. 舒适和有意义的活动
4. 享受当下
5. 保持自主性

痴呆症患者的需求取决于其日常生活的情绪因素 (n=36)

对心理症状和行为症状的五大影响因素:

- 身体原因, 尤其是疼痛
- 心理需求
- 情感
- 沟通
- 无法胜任

Cunnigham 等人2019 年找到50 多个影响因素。

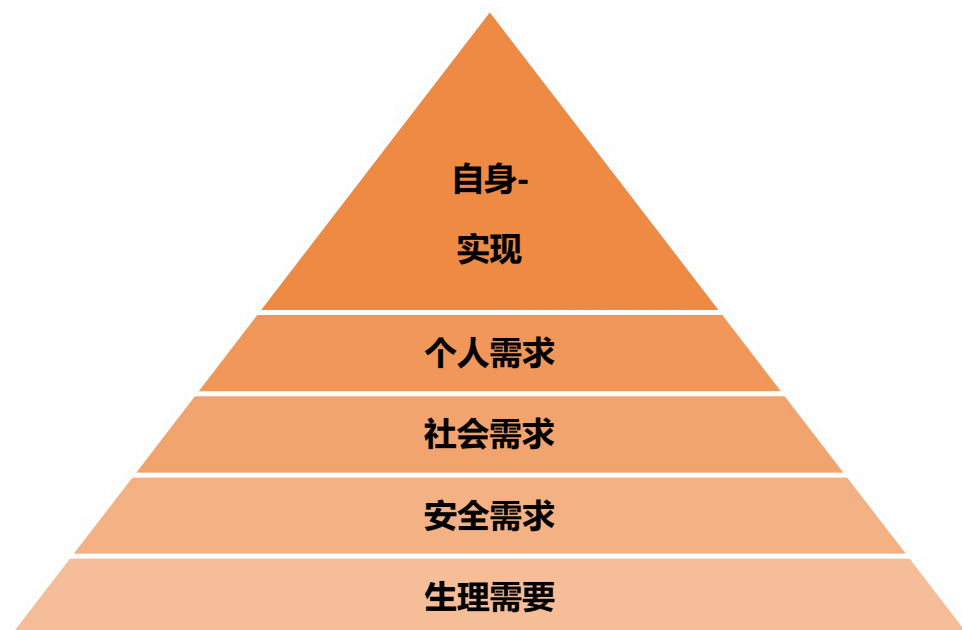
而心理和行为症状的起因是多因素的。

心理和行为症状可以理解为信号行为。

强化痴呆症患者的自主性

- 接受患者的,,不“或者拒绝作为其自由的意志表达
- 应对每天的情绪波动
- 确定压力情况, 例如强调个人卫生会被视为侵犯其个人操守
- 辨认出患者满足感的表达
- 支持并鼓励主动行为
- 灵活安排时间
- 就行为症状进行事后沟通
- 建立行为症状的解释模型

根据 Kostrzewa S. 2023 , 对待痴呆患者应该持有容许的基本态度。

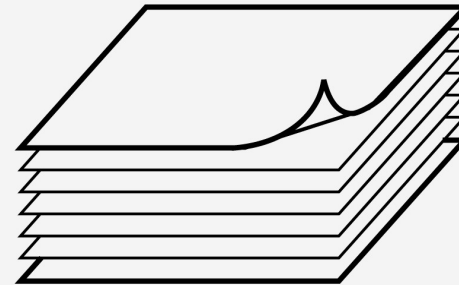


- **自我实现:** 有意义的工作、自立
- **个人需求:** 认可, 自我形象/自尊
- **社会需求:** 参与、联系/爱
- **安全需求:** 定位、安慰/亲近
- **生理需要:** 饥饿、口渴、运动

第七章: 规划和准备



治疗单元安排



材料清单

基本要求

- **合适的治疗室**
- **治疗师安排**（请假或病假）-- 尽可能避免治疗师的频繁变换
- **准备工作需要时间**
- **预备好所需材料**

提示：

- 为了使MAKS疗法®顺利进行，在www.clarcert.de 的下载区为设施管理者和MAKS® 治疗师提供了信息资料。

- 无障碍设施
- 保证光线和室温
- 邻近厨房
- 紧邻厕所
- 尽可能不是“过道间”（保证安静）。
- 总是在同一个地方
- 有足够地方形成一个的椅子圈
- 笔记本电脑、投影仪置放、屏幕

希望进行MAKS® 治疗的治疗师人，必须...

- **成功地完成了**为期3天的、并由持有执照的MAKS® -讲师授课的MAKS®治疗师培训课程。
- 有至少6个月的与认知障碍患者接触的相关工作经验。

每个**MAKS®** 小组始终都是由**两个治疗师来领导的**。

- 10-12名轻度认知障碍（MCI）、轻度痴呆或中度痴呆患者（MMST $\geq$ 10；最好 >14 ）。
- 严重痴呆症患者（MMST <10 ）应接受**MAKS**[®]-s干预。
- 如有必要，进行MMST测试以划分组别。

一般来说:

- 椅子、桌子
- 电脑和投影仪
- 給椅子圈配的小桌

MAKS® -特定的:

- 材料清单: “**基本用具**”和 “**特殊练习所需用具**”见数字手册

如何确保MAKS-m的疗效



MAKS-m疗法的有效性已经在科学研究中得到证实，它是建立在符合以下最低要求的**MAKS®**的系统的和定期实施的基础上：

- 按顺序完成所有4个模块S-M-K-A（缺一不可）（相当于一个治疗单元）。
- 四个模块中包含的内容（仪式、热身练习、主要部分练习）必须全部完成（而不仅仅是其中的一部分），而这些内容大部分来自MAKS-m数字手册。
- 每周至少进行1-2次治疗单元。

因此，人类的昼夜节律是相似的。然而，痴呆患者的昼夜节律可能会受到干扰，例如昼夜节律紊乱和睡眠障碍（如入睡时间延长、频繁醒来、白天嗜睡）。

日落 "综合征： 痴 呆 患 者 在下午或晚上由于储备的耗尽而导致认知状态的恶化（Schwerthöfler D., Förstl H. DNP 21; 18-22 (2022).它还包括情绪和行为症状的增加。

由于痴呆症患者的认知能力在一天中经常恶化，在上午进行MAKS-m治疗是最有意义的。

问题：在MAKS-m治疗中只能使用数字手册中的练习吗？

负责该治疗方案的Elmar Gräbel教授2023年3月12日做出以下声明：

“基本上，对于每一种疗法，其效果都是基于一定的、经过测试的程序：只有那些按照这个程序实施的人，才能达到之前确定的效果。这一原则也适用于MAKS疗法！

任何完全使用其他练习的人都不是在实施MAKS疗法！- MAKS疗法的成功是基于手册中公布的练习（以数字手册的形式提供）。

当然，对于有经验的MAKS治疗师来说，可以对原有的MAKS练习的进行变化，甚至“发明”新的练习，并在实践中证明是成功的。MAKS疗法不是一个“僵化的系统”。

综上所述：没有手册，就没有MAKS；如果你在MAKS的基础知识指导下，你自己的练习可以补充手册的内容--在培训中教授。

因此，MAKS疗法成功的基础一方面是培训，另一方面是电子手册。

数字MAKS®的概述 - 手册



感谢您的关注!

...我们祝愿你在实践阶段获得更多的乐趣